

2022/2023

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTE DE MEDECINE DE CONSTANTINE
SERVICE DE MEDECINE INTERNE
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE BENBADIS DE CONSTANTINE

[TROUBLES DE LA SENSIBILITÉ]

Pr N Benmostefa

Objectifs pédagogiques

Connaitre et faire le diagnostic :

- Des différents syndromes sensitifs périphériques et centraux.
- De la tétanie

Plan

1	LES DIFFERENTS SYNDROMES SENSITIFS.....	2
1.1	Les syndromes sensitifs d'origine périphérique.....	2
1.1.1	Mononévrite :.....	2
1.1.2	Polynévrite :.....	2
1.1.3	Monoradiculite :.....	2
1.1.4	Polyradiculonévrite :.....	3
1.2	Les syndromes sensitifs centraux.....	3
1.2.1	Au niveau de la moelle :.....	3
1.2.2	Au niveau du bulbe :.....	5
1.2.3	Au niveau du thalamus :.....	5
1.2.4	Au niveau du cortex :.....	6
2	La tétanie.....	6
3	Bibliographie.....	7

Liste des figures

Figure 1 : lésion d'une héli-moelle	4
Figure 2 : main de l'accoucheur	6

1 LES DIFFERENTS SYNDROMES SENSITIFS

1.1 Les syndromes sensitifs d'origine périphérique

Ils sont dus à une atteinte des troncs nerveux ou des racines.

1.1.1 Mononévrite :

Est caractérisée par l'atteinte d'un seul tronc nerveux.

— *Signes fonctionnels* : le patient se plaint de **paresthésies** et de **douleurs** dans le **territoire de distribution sensitive** du **nerf atteint**. Les douleurs peuvent être déclenchées ou accentuées par l'application d'une pression en certains zones du tronc nerveux.

— *Examen clinique* : objectivement on retrouve une **hypoesthésie** ou une **anesthésie** à tous les modes de la sensibilité dans le **territoire de distribution sensitive** associés à des **troubles moteurs** dans le **territoire de distribution motrice du nerf** en question.

1.1.2 Polynévrite :

Définie par l'atteinte **symétrique** et bilatérale de **plusieurs troncs nerveux** avec une **localisation** habituellement **distale** des troubles.

— *Signes fonctionnels* : représentées par des **paresthésies** et des **douleurs profondes**.

— *Examen clinique* : retrouve le plus souvent une **hypoesthésie cutanée** et parfois des troubles de la sensibilité profonde.

L'atteinte sensitive est particulière bilatérale, **symétrique**, **distale** touchant les extrémités avec une **topographie « en gant » ou « en chaussette »**. Elle est **associée à des troubles moteurs** affectant **les extenseurs des doigts** aux membres supérieurs **et la loge antéro-externe des jambes** aux membres inférieurs.

1.1.3 Monoradiculite :

Est définie par l'atteinte d'une seule racine nerveuse.

— *Signes fonctionnels* : sont au **premier plan**, dominés par **la douleur de type radiculaire** : qui suit le trajet de la racine, elle est déclenchée ou augmentée par les manœuvres qui augmentent la pression dans le LCR et par les manœuvres d'étirement de la racine. On peut retrouver parfois des paresthésies.

— *Examen clinique* : d'habitude discrets à type d'**hypoesthésie** à tous les modes dans le territoire de distribution sensitive de la racine atteinte. Les **troubles moteurs** sont également plutôt **discrets**.

1.1.4 Polyradiculonévrite :

Se définissant par l'atteinte symétrique et bilatérale de plusieurs racines nerveuses.

— *Signes fonctionnels* : sont au premier plan à type de **paresthésies** et **parfois de douleurs**.

— *Examen clinique* : **pas de troubles sensitifs**, cependant il existe des **troubles moteurs symétriques et diffus** intéressant les **nerfs crâniens et les membres**.

— Le **LCR** est caractéristique, il met en évidence une **dissociation albumino-cytologique** (hyperalbuminorachie avec cytologie normale).

1.2 Les syndromes sensitifs centraux

Ils peuvent avoir pour origine une atteinte de la **moelle**, du **bulbe**, du **thalamus** ou du cortex.

1.2.1 Au niveau de la moelle :

Il peut s'agir d'un syndrome **médullaire complet** ou **partiel**.

1.2.1.1 Le syndrome médullaire complet :

Il évolue en deux étapes :

Dans un premier lieu, un tableau dit **choc spinal** de paraplégie ou d'une tétraplégie flasque s'installe avec anesthésie totale ou **hypoesthésie à tous les modes** dans le **territoire** sensitif situé **en-dessous de la lésion** ainsi que des troubles sphinctériens (rétention des urines et des selles). La limite supérieure du trouble de la sensibilité à une valeur capitale pour le diagnostic topographique de la lésion médullaire plus particulièrement en cas de compression médullaire.

Secondairement, **un automatisme médullaire** s'installe ; les réflexes ostéo-tendineux réapparaissent, et une hypertonie pyramidale (spasticité) s'installe. Le signe de Babinski apparaît en premier lieu : puis c'est le réflexe du triple retrait, très caractéristique d'une lésion médullaire : En pinçant ou en touchant le cou-de-pied, une triple flexion du pied apparaît sur la jambe (dorsiflexion), de la jambe sur la cuisse, de la cuisse sur le bassin. La percussion du pubis peut déclencher des mictions réflexes.

Tout syndrome médullaire nécessite une prise en charge urgente. Il est la conséquence d'un processus aigu de nature **traumatique, ischémique ou nécrosante inflammatoire**.

1.2.1.2 Les syndromes médullaires partiels :

peuvent revêtir plusieurs aspects :

— **Une lésion de l'hémi-moelle** droite ou gauche réalise le **syndrome de Brown-Sequard** qui associe (Fig1) :

- **Du côté de la lésion** : du côté de la lésion, un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur avec des **troubles** de la **sensibilité profonde** et des **troubles moteurs** à type de **paralysie**.

- Du côté opposé à la lésion : syndrome spino-thalamique avec des **troubles** de la **sensibilité thermo-algésique**.

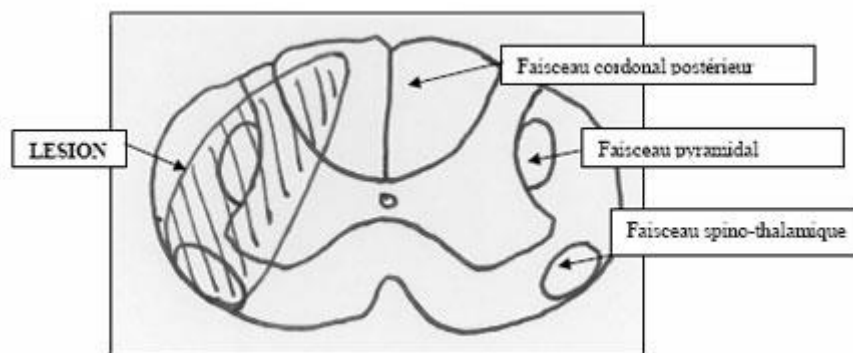


Figure 1 : lésion d'une hémimoelle

— Une lésion des cordons postérieurs réalise le **syndrome cordonal postérieur** : le patient rapporte des *troubles sensitifs* subjectifs : la plus caractéristique, est la **douleur fulgurante** ou **en éclair**.

Les *troubles sensitifs* objectifs ne vont intéresser que la **sensibilité profonde** :

- Une **ataxie** : troubles moteurs qui apparaissent lors de la fermeture des yeux :

- **troubles du maintien des attitudes** : signe de Romberg vrai et signe de la main instable ataxique : en demandant au patient de maintenir ses mains tendues en avant, les doigts écartés, en fermant les yeux, des oscillations de la main et les doigts apparaissent.

- **troubles des mouvements** : avec troubles de la marche : **démarche talonnante** avec **anomalies du mouvement finalisé** : dysmétrie, le mouvement est mal dirigé, hésitant et le but est manqué :

- Une *abolition* de la *sensibilité vibratoire au diapason*.

- Une *perte du sens de positionnement segmentaire des membres* (gros orteil et autre).

- Une *astéréognosie* : perte de la reconnaissance palpatoire des objets (yeux fermés). En absence de troubles de la sensibilité thermo-algésique d'où le nom de dissociation tabétique : car ce tableau a d'abord été décrit dans le tabès (syphilis nerveuse), peut se voir aussi au cours de l'avitaminose B 12.

— Une **lésion centro-médullaire** : elle résulte d'un processus de cavitation centro-médullaire de nature primitive en rapport avec une cavité liquidienne (hydromyélie) ou une tumeur (épendymome).

Réalise des **troubles isolés de la sensibilité thermo-algésique** « **en bande** » ou « **suspendue** » avec **conservation de la sensibilité profonde et tactile**, c'est la classique dissociation syringomyélique ou thermo-algésique rencontrée dans la syringomyélie et les tumeurs intramédullaires.

La lésion concerne au niveau du renflement cervical en hauteur quelques métamères d'où l'aspect suspendu des lésions et en largeur les fibres spino-thalamiques, mais aussi la corne antérieure, d'où l'association caractéristique :

- anesthésie thermo-algésique en bande avec conservation de la sensibilité profonde associés à des douleurs spino-thalamiques (brûlures) ;
- troubles trophiques des membres supérieurs secondaires à l'insensibilité à la douleur : multiples cicatrices des mains ;
- paralysie avec amyotrophie de la ceinture scapulaire, des bras et des mains.

1.2.2 Au niveau du bulbe :

Le syndrome de Wallenberg par atteinte de la région latérale du bulbe : syndrome sensitif alterne (dû à un ramollissement du bulbe par ischémie artérielle dans le territoire vertébro-basilaire).

— Du côté de la lésion : une hypoesthésie ou une anesthésie thermo-algésique dans le territoire du nerf trijumeau sans atteinte de la sensibilité tactile (s'étendant sur toute la hauteur du bulbe, parmi les noyaux sensitifs du V, seul le noyau spinal est touché, et il est le relais des afférences thermiques et douloureuses ; le noyau principal du V, noyau de la sensibilité tactile, siège au niveau de la protubérance), un syndrome vestibulaire, un syndrome de Claude Bernard Horner, et un hémisindrome cérébelleux.

— Du côté opposé à la lésion : une hémianesthésie thermo-algésique des membres supérieurs et inférieurs réalisant avec l'anesthésie faciale du côté de la lésion, le syndrome sensitif alterne ; une hémiparésie est possible.

1.2.3 Au niveau du thalamus :

C'est le syndrome capsulo-thalamique de Dejerine-Roussy : la lésion intéresse le noyau postéro-ventral du thalamus et déborde sur la capsule interne et les radiations optiques ; il va se manifester du côté opposé à la lésion :

- Des troubles sensitifs subjectifs à type d'hyperpathie.
- Des troubles de la sensibilité profonde et des troubles de la sensibilité thermo-algésique.
- Une hémianopsie latérale homonyme.
- Une hémiparésie.

1.2.4 Au niveau du cortex :

Des lésions du cortex pariétal vont entraîner des troubles sensitifs de la moitié opposée du corps souvent limités à une partie du corps du fait de l'étalement de la représentation somatotopique sensitive.

Ces troubles sensitifs portent essentiellement sur la sensibilité profonde : trouble du sens des positions sédentaires et astéréognosie. Les troubles de la sensibilité superficielle sont seulement à type d'hypoesthésie.

2 La tétanie

Définition : est un **syndrome sensitivo-moteur** évoluant par **crises paroxystiques**.

L'accès tétanique : comporte des **troubles sensitifs** et des troubles **moteurs** dont la répartition topographique est particulière ; ils affectent les **extrémités : mains, pieds**, et la région **péribuccale**.

— *Les troubles sensitifs :* sont constants.

— **Troubles subjectifs :** à type de **paresthésies** : fourmillements et picotements, puis impression d'enraidissement.

— **Troubles objectifs : hypoesthésie tactile et profonde.**

— *Les troubles moteurs :* sont des **contractions** soutenues, involontaires et incoercibles d'intensité modérée, **non douloureuses**.

— **La main d'accoucheur : (Fig 2)**

- le pouce en extension et adduction,
- les doigts serrés les uns contre les autres à demi fléchis,
- la paume est creusée par le rapprochement de ses deux bords
- le poignet peut être en demi-flexion.

Lorsque les pieds sont atteints, les orteils se mettent en flexion plantaire serrés les uns contre les autres, la plante est creusée comme la paume de la main.

- La crise commence par des troubles sensitifs débutant par les doigts et les orteils **sans jamais dépasser le coude, ni le genou**, puis apparaissent les troubles moteurs. La durée de la crise va de **quelques minutes à quelques heures**.



Figure 2 : main de l'accoucheur

Entre les crises : des troubles sensitifs objectifs à type d'hypoesthésie tactile des doigts peuvent persister.

On recherchera :

le signe de Chvostek : contraction de l'orbiculaire des **lèvres** lors de la percussion de la joue au milieu d'une ligne unissant le lobule de l'oreille et la commissure labiale;

le signe de Weiss : contraction de l'orbiculaire des **paupières** lors de la percussion de l'angle externe de l'oeil

le signe de Lust : contraction **des muscles de la loge antéro-externe** de la **jambe** lors de la percussion du sciatique poplité externe au col du péroné.

Tous ces signes peuvent être négatifs, on essaiera alors donc de déclencher un accès tétanique par l'épreuve du garrot qui consiste à poser sur le bras pendant 10 minutes un garrot ischémiant, puis à l'enlever, chez le tétanique cette manoeuvre déclenche un accès c'est le signe de Trousseau.

Les causes des tétanies : l'hypocalcémie, l'alcalose, l'hypokaliémie et les tétanies idiopathiques (sans cause décelable).

3 Bibliographie

Précis de sémiologie. Rose-Marie Hamladji.